

KC桌面——外资精译

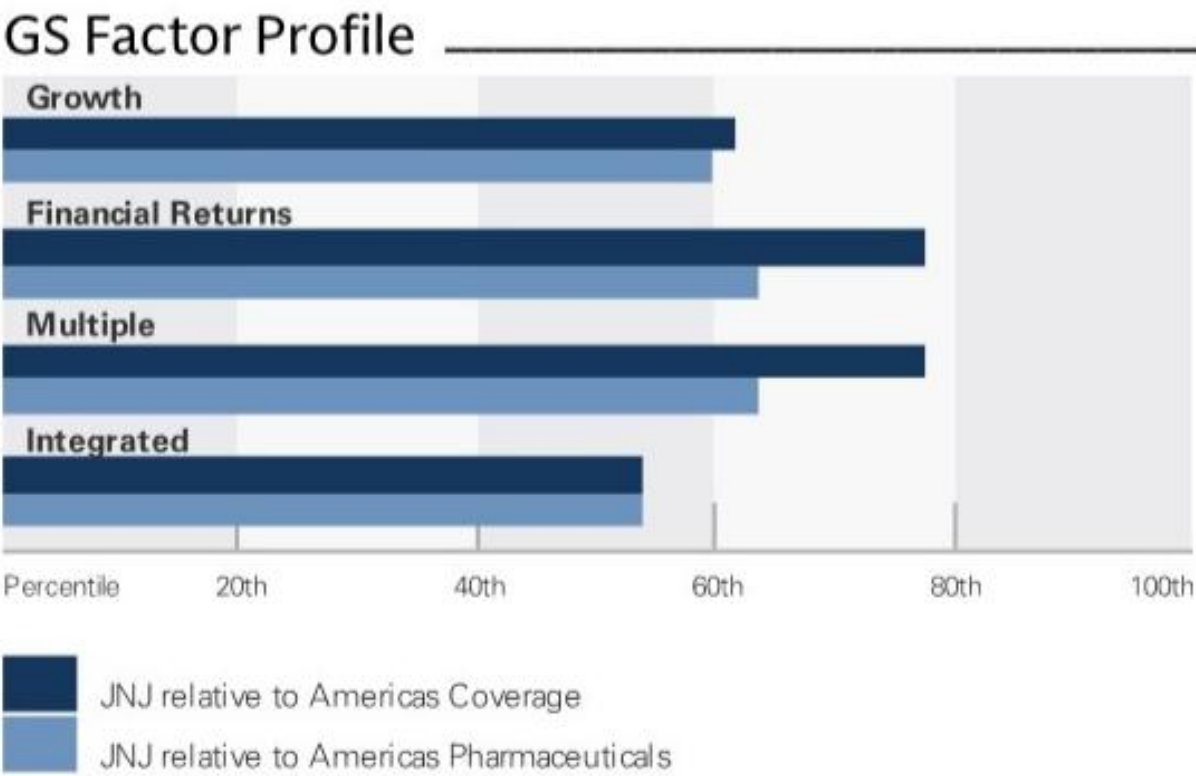
GS：GS调研，强生口服银屑病药Icodyde或成百亿美元重磅产品

KOL调研看好Icodyde在银屑病领域的潜力和定位

JNJ近期推出的口服银屑病药物Icodyde，代表了公司免疫学业务线中一个关键的新产品周期。管理层将其定位为有潜力成为公司有史以来最大的产品之一，使其成为公司在本十年末实现两位数营收增长目标的关键拼图。继3月获得FDA批准用于中重度斑块状银屑病后，在4月中旬的1Q26财报电话会议上，JNJ强调了积极的早期上市指标，指出已有1,500名患者获得处方，涉及超过1,000名独立处方医生；随后，在6月9日的医疗保健会议上，公司披露处方医生数量已增至约4,500名，呈现陡峭增长。公司表示IQVIA尚未覆盖所有渠道，暗示公开处方数据可能低估了实际需求。JNJ下周公布的2Q26财报业绩（此处参见我们的预览）将是Icodyde首个完整季度的销售数据，我们预计管理层将提供更新的上市指标，尽管尚未单独披露产品层面的销售额。除银屑病外，Icodyde还在开发用于银屑病关节炎（PsA）、溃疡性结肠炎（UC）和克罗恩病（CD），管理层此前曾表示，到2027年，Icodyde将在企业层面成为有意义的营收驱动力。

为评估Icodyde的上市进展和长期定位，我们上周对26名皮肤科医生进行了一项专项调研。我们注意到以下关键结论

- 皮肤科医生预计，针对中重度银屑病患者的Icodyde处方量将显著增长——从目前的约2-3%增至1年后的约8-10%，并在5年内达到15-20%。
- Icodyde被认为最适合新使用品牌全身性治疗的患者，或从其他口服品牌（如AMGN的Otezla和BMY的Sotyktu）转换而来的患者。虽然预计会从其他品牌



图表 1

来源：公司数据，GS估计。详情请参阅披露信息。



图表 2

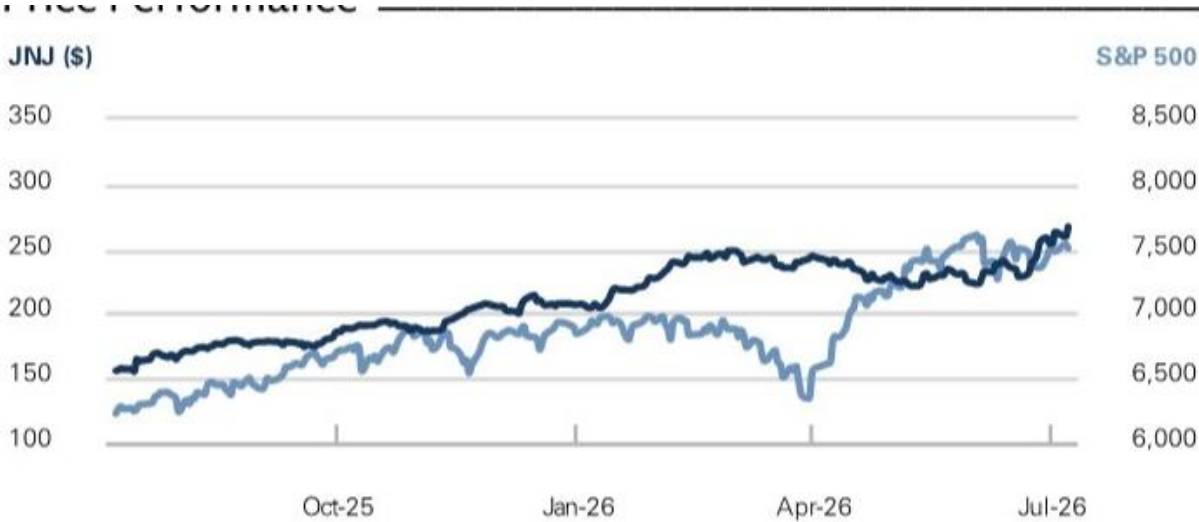
Johnson & Johnson (JNJ)

自2025年4月8日起评级

比率与估值

增长与利润率 (%)

资产负债表 (百万美元)



图表 3

来源：FactSet。价格截至2026年7月7日收盘。

利润表 (百万美元)

来源：公司数据，GS估计。

口服药物转换至Icotyde，但预计从注射用IL-23或IL-17药物转换的比例不高。约50%的新患者仍首选注射用IL-23药物（如ABBV的Skyrizi和JNJ的Tremfya）。

- 处方决策的关键因素是疗效和口服给药方式，而Icotyde的空腹要求并未构成障碍。

总体而言，我们认为调研结果与JNJ（及ABBV）传达的信息一致，即Icotyde可能扩大银屑病治疗市场，而非蚕食IL-23注射剂（如Tremfya和Skyrizi）的市场份额。值得注意的是，如果Icotyde达到我们调研中KOL所指出的15-20%市场份额，这可能支撑超过100亿美元的峰值营收（而GS估计为77亿美元/Visible Alpha共识数据为71亿美元），并可能从PsA、UC和CD等其他适应症中获得上行空间。

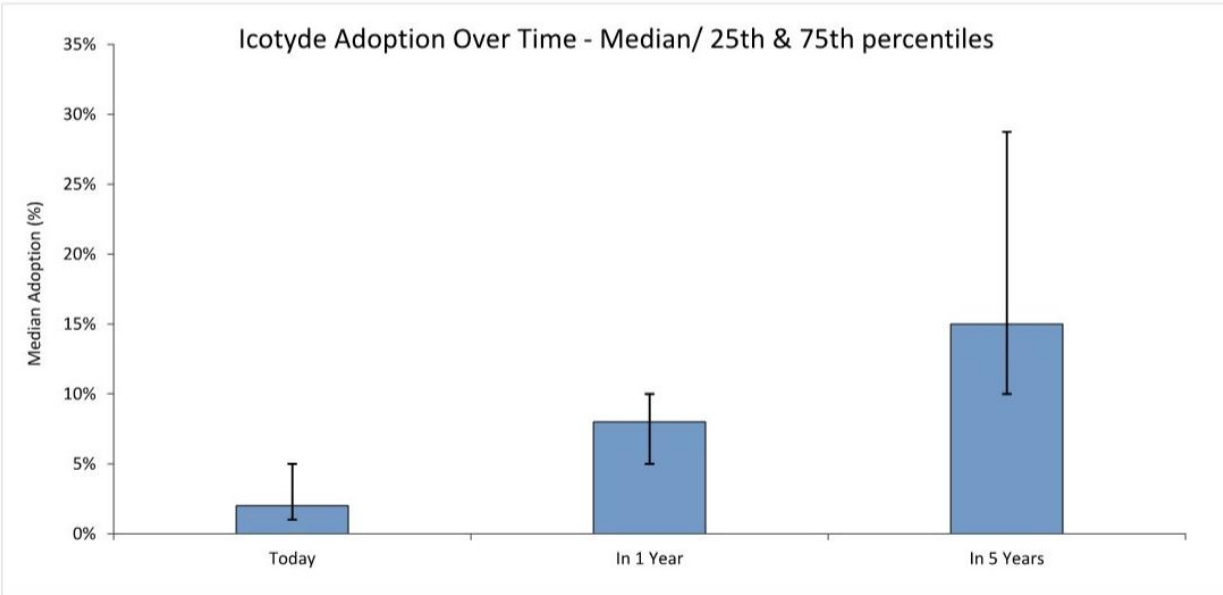
详见下文。

Icotyde KOL调研详细结果

我们调研了26名皮肤科医生，每位医生至少治疗100名中重度银屑病患者，并在过去一年中开具过多种品牌全身性治疗药物。

问题1：截至目前，您有多少比例的中重度银屑病患者已使用Icodyde处方？您预计1年后和5年后的比例是多少？

图表1：皮肤科医生预计将增加对中重度银屑病患者Icodyde处方量

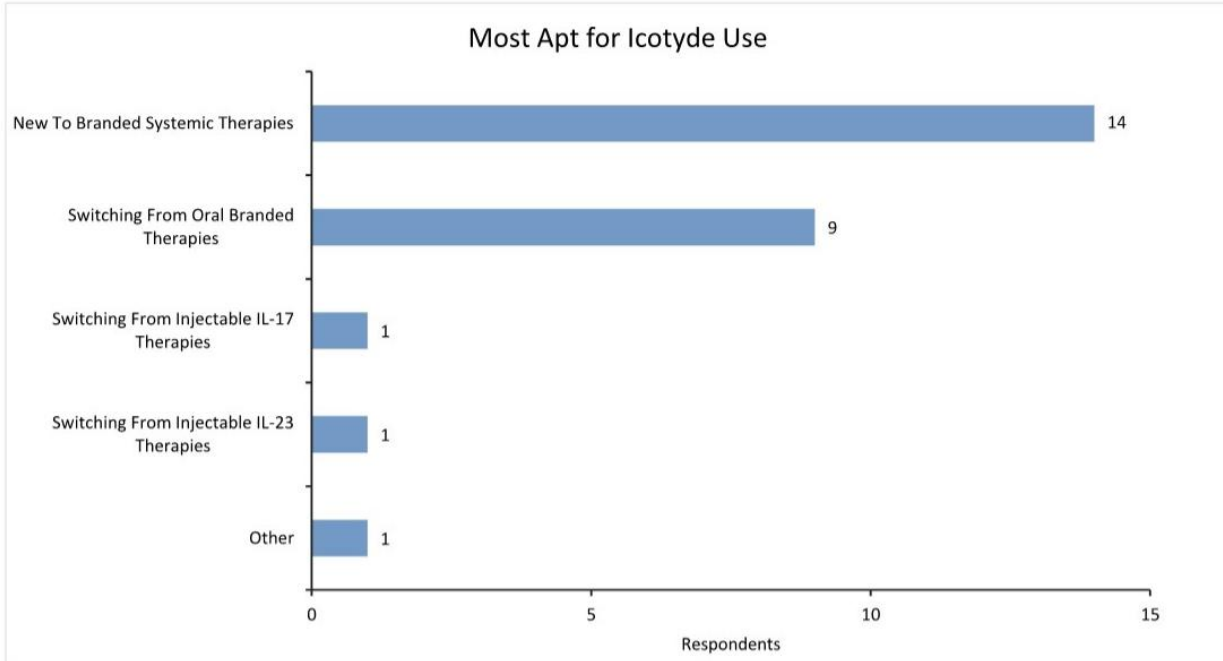


图表 4

皮肤科医生表示，目前他们已对合格人群开具Icodyde处方的平均/中位数比例为3%/2%，预计1年后将增至10%/8%，5年后增至19%/15%。有趣的是，观察第25和第75百分位数，虽然第25百分位数遵循类似的增长轨迹（从1%到5%到10%），但第75百分位数显示5年后比例偏向上限至29%——这向我们表明，许多医生认为Icodyde的使用量会随时间推移而增加，代表潜在上行空间。

问题2：您认为中重度银屑病患者中，哪些现有群体最适合使用Icodyde？

图表2：Icodyde患者预计主要来自新使用品牌全身性治疗或从口服品牌转换

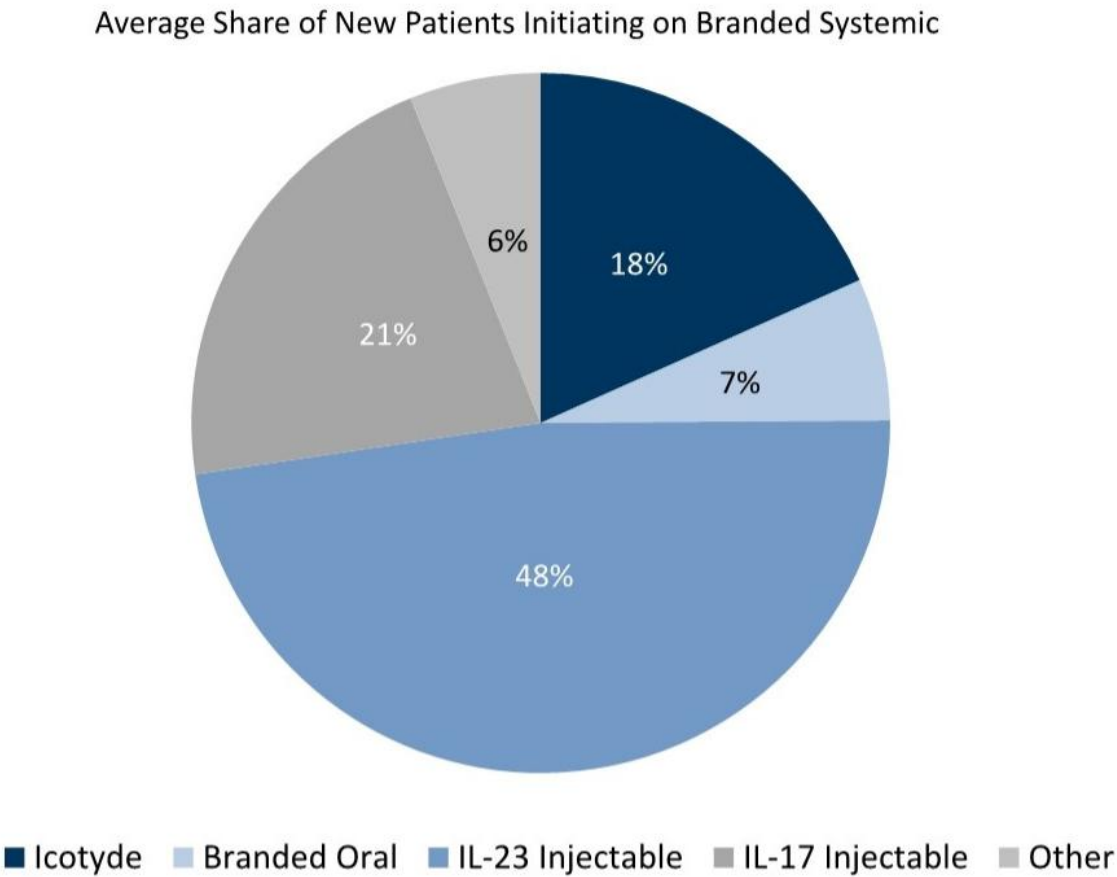


图表 5

我们认为这些调研回复与JNJ关于Icodyde相对于Tremfya（以及ABBV关于相对于Skyrizi）的评论一致。JNJ指出，Icodyde被定位为一线全身性治疗，适合从局部治疗或现有口服疗法（如Otezla或Sotyktu）过渡、但对开始使用注射生物制剂犹豫不决的患者。管理层认为，口服IL-23肽的引入将扩大晚期全身性治疗市场，而非抢占Tremfya的市场份额。在全球医疗保健会议上，JNJ指出，约60%的早期Icodyde患者未接受过全身性治疗，约25%的患者从现有口服治疗转换而来，这与我们的调研方向一致。

问题3：在开始使用品牌全身性治疗药物的新患者中，您预计会开具以下药物的比例是多少？

图表3：对于中重度银屑病患者，IL-23和IL-17注射剂总体上仍受青睐

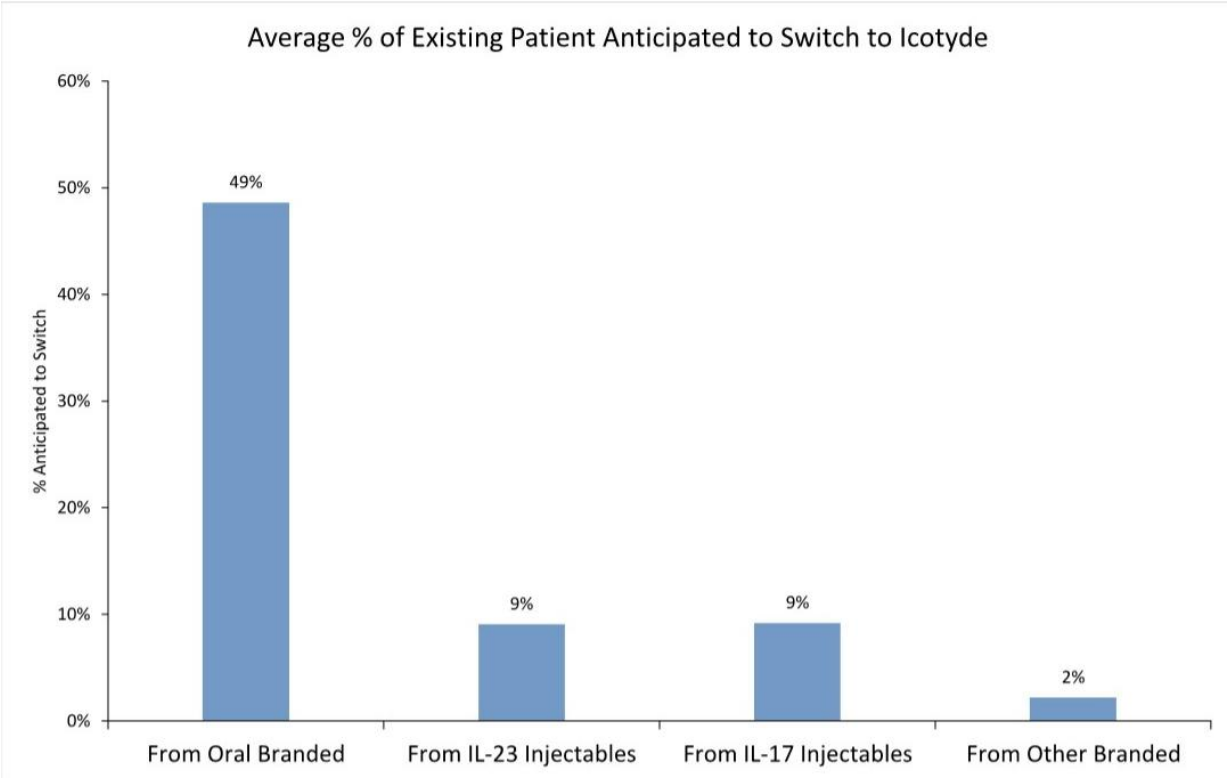


图表 6

与前一问题的回复一致，注射用IL-23药物（如Tremfya和Skyrizi）平均而言被约一半的新患者所青睐。我们的调研显示，皮肤科医生平均而言略微倾向于将注射用IL-17作为次选，但紧随其后的是Ictocyte。

问题4：在现有患者中，您预计有多少比例会转换至Ictocyte……来自口服品牌疗法？来自品牌注射剂？

图表4：预计从其他口服品牌选项会有显著转换，但来自IL-23或IL-17注射剂的转换不多

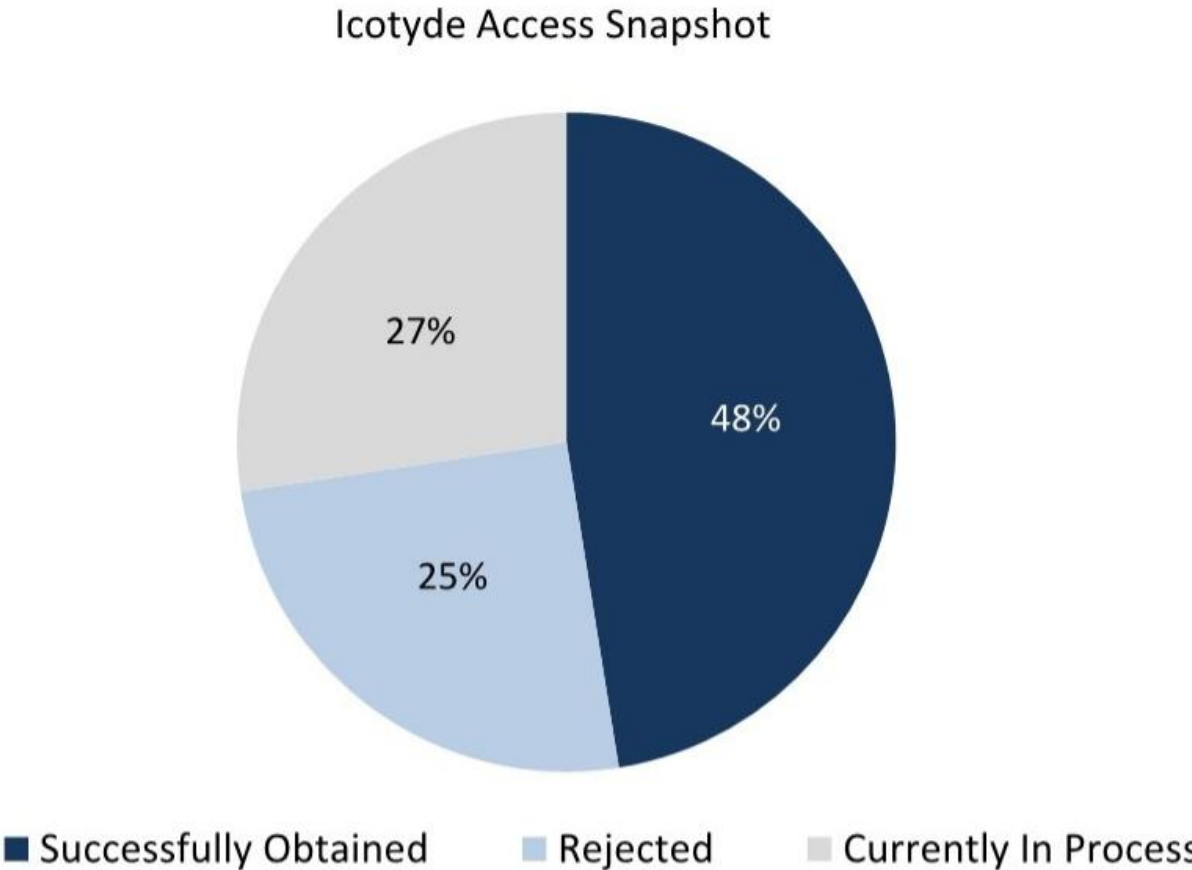


图表 7

虽然预计约一半使用口服品牌疗法（如Otezla和Sotyktu）的患者会转换至Icotyde（鉴于类似给药方式下疗效更高，这在我们看来合乎逻辑），但预计只有个位数百分比的现有注射用IL-23或IL-17药物患者会转换（这也合乎逻辑，因为我们理解医生不愿转换现有治疗稳定的患者，且注射剂通常提供每月至每季度给药一次的便捷方案）。

问题5：对于您尝试开具Icotyde处方的患者，保险覆盖/准入结果如何？

图表5：皮肤科医生表示准入成功率为2:1，尽管尚处早期，许多仍在处理中



图表 8

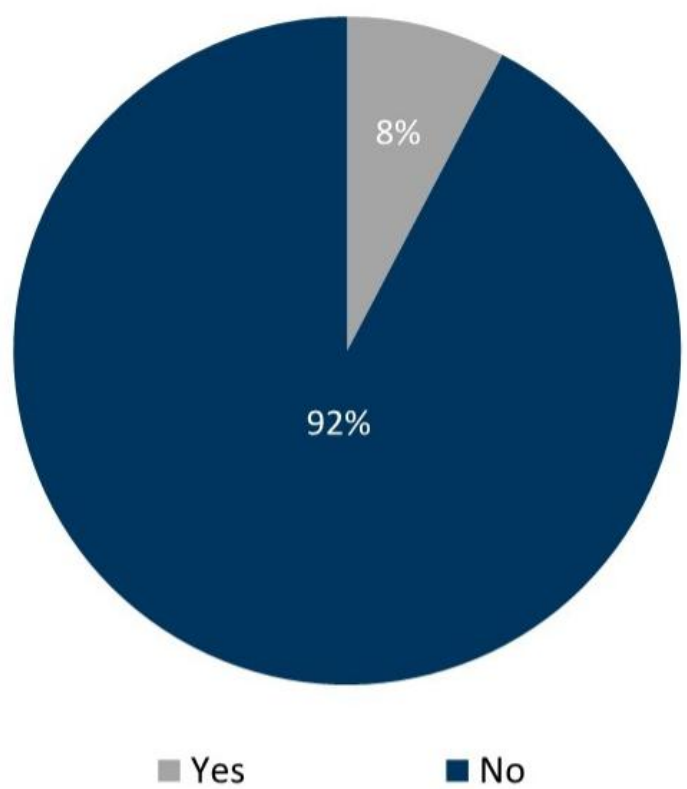
我们认为，调查显示约半数处方患者成功获取Icotyde，成功率约为2:1，且许多处方仍在进行中，这一结果令人鼓舞。随着产品上市逐步成熟，医生和支付方积累更多经验并更熟悉物流流程，我们认为这一比例有望进一步提升。

第六题：30分钟空腹服药是否成为处方障碍？

图表6：30分钟空腹服药要求绝大多数情况下未构成障碍

空腹要求作为障碍

Fasting Requirement as a Barrier

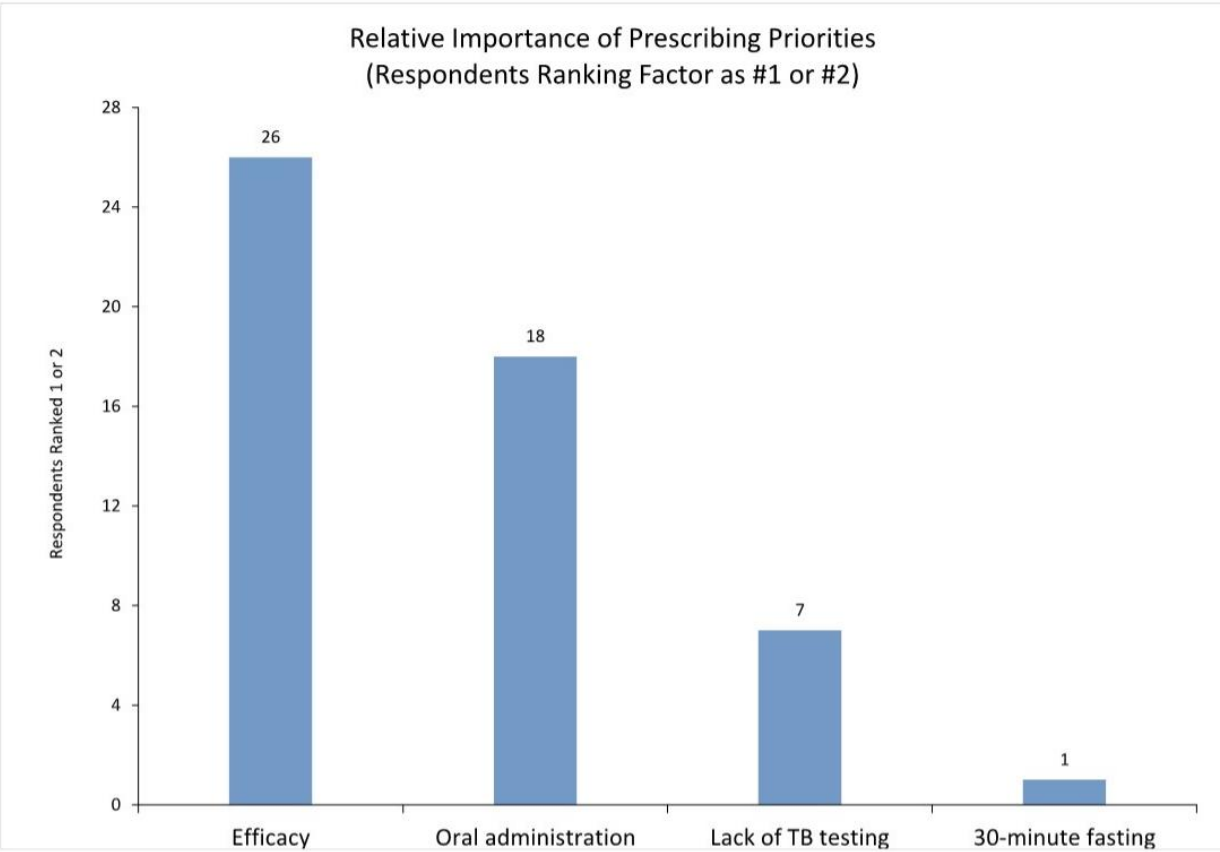


图表 9

令人鼓舞的是，绝大多数医生认为食物影响/空腹要求并未成为处方Icotyde的障碍。

第七题：请对您处方时考虑的各因素按重要性排序

图表7：疗效与口服给药是Icotyde处方的首要驱动因素



图表 10

我们认为调查中皮肤科医生对处方因素的排序合理，且与其他调查结果一致，疗效与口服给药位列前两位。从疗效角度看，Icotyde优于其他现有口服疗法，但略逊于注射类IL-23抑制剂——不过其口服差异化优势得以体现。结核病检测缺失被视为较次要因素，而30分钟空腹要求被认为最不重要。

估值与不确定性

估值：我们基于第五至第八季度每股收益的20倍市盈率。

主要节奏变化不确定性：新产品推广速度可能慢于预期，导致收入不足以弥补下滑产品。与滑石粉诉讼相关的进一步不确定性可能导致赔付高于预期并压制估值倍数。宏观环境及关税相关的外部环境更趋复杂，可能使我们的预测面临节奏变化不确定性。